

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Regione Lombardia

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza (112)

MODULO SSE CAPITOLO 2

URGENZE PEDIATRICHE

Addetto Al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU

SSE

OBIETTIVI

SAPER IDENTIFICARE LE PRINCIPALI CAUSE DI URGENZE PEDIATRICHE

CONOSCERE I RELATIVI PRINCIPI DI ASSISTENZA

SSE

La comunicazione è la chiave per fornire la migliore assistenza

Il bambino ha differenti modi per farsi capire rispetto al mondo degli adulti

Ha paure e stress differenti

Dobbiamo trattare il bambino coinvolgendo la famiglia e/o i tutori

SSE

Classificazione in base all'età cognitiva/relazionale

- Neonato: alla nascita*
- Infante: dalla nascita a 1 anno
- Bimbo ai primi passi: 1-3 anni
- In età prescolare: 3-5 anni
- In età scolare: 5-10 anni
- Adolescente: 10-17 anni

SSE

Infante (dalla nascita ad 1 anno)

- Dipende completamente dai genitori
- Sta seduto, gattona
- Segue con lo sguardo, attirato da suoni e luci
- Respira attraverso il naso e usa prevalentemente i muscoli addominali
- Scarsa capacità di termoregolazione
- Testa grossa: fonte di perdita di calore

SSE

Infante (dalla nascita ad 1 anno)

ASSISTENZA

- LASCIALO VICINO AI GENITORI
- TIENILO AL CALDO
- USA UN TONO DI VOCE CALMO E RASSICURANTE

SSE

Bimbo ai primi passi (da 1 a 3 anni)



- Comincia a parlare
- Ha coscienza di sé, esprime volontà
- Teme le separazioni e il dolore
- Cammina ed esplora il mondo che lo circonda
- Non avverte il pericolo
- Esegue ordini semplici

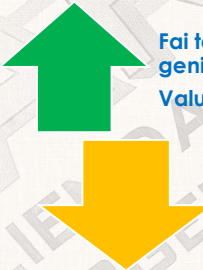
WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Bimbo ai primi passi (da 1 a 3 anni)



ASSISTENZA



- Fai tenere sempre il contatto visivo con i genitori, se possibile
- Valutalo con i genitori vicini, se possibile
- Mettiti al loro livello (altezza)

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Età prescolare (da 3 a 5 anni)



- E' molto espressivo e comunicativo
- E' un pensatore magico e fantasioso
- Ha un concetto di sé ancora incompleto
- Teme il dolore, le deturpazioni e le separazioni
- E' spesso iperattivo

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Età prescolare (da 3 a 5 anni)



ASSISTENZA

- Incoraggia la partecipazione al trattamento
- Trasporta con il bimbo il giocattolo o l'indumento preferito
- Incoraggia il gioco e la fantasia



WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Età scolare (da 5 a 10 anni)



- Si esprime correttamente
- Capisce la struttura e le funzioni del corpo
- Ragiona
- Non comprende il concetto di morte
- Teme la perdita di funzioni e le deturpazioni

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Età scolare (da 5 a 10 anni)



ASSISTENZA



- Spiega le procedure prima di eseguirle
- Spiega la motivazione delle procedure
- Prospetta un'evoluzione favorevole trauma
- Rispetta il suo pudore
- Loda la sua collaborazione

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Adolescenza (da 10 a 17 anni)

- E' determinato a vivere nuove esperienze
- Ha capacità decisionale
- Il suo riferimento è spesso il gruppo di amici
- Teme la perdita di autonomia
- Teme la deturpazione e la morte

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Adolescenza (da 10 a 17 anni)

ASSISTENZA

- Raccogli informazioni in assenza dei genitori, se necessario
- Consentigli di fare scelte e mantenere il controllo della situazione
- Rispetta la sua autonomia
- Non ridicolizzarlo di fronte agli altri

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

TABELLA Parametri Vitali e Peso Corporeo

Età	FR (a/min)	FC (b/min)	PAS (mmHg)	Peso (Kg)
infante	30-40	120-150	70-80	3-10
2-4 anni	20-30	100-110	80-95	12-16
5-8 anni	14-20	90-100	90-100	18-26
8-12 anni	12-20	80-100	100-110	26-50
> 12 anni	12-16	60-90	100-120	> 50

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Rilevazione Frequenza Cardiaca

RILEVAZIONE DEL POLSO

BAMBINO:
Carotideo
Radiale Brachiale

INFANTE:
Brachiale

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Rilevazione Saturazione di O2

ATTENZIONE AI LIMITI DELLO STRUMENTO !!

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Valutazione primaria

Chiedi al genitore o tutore:
"il bambino non si comporta nel solito modo"

- meno attento
- meno interattivo
- inconsolabile
- non distraibile
- indifferente alle cose circostanti

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Valutazione primaria

ABCDE

AVPU

Attività motoria:
simmetrica
coordinata
finalistica

Postura
Flaccidità

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Valutazione primaria

AMPIA - Anamnesi

- Tempo di insorgenza dei sintomi ?
- Patologie note ?
- Assunzione cibo (ultimo pasto)
- Assunzione di medicinali ?
- Se non è il primo episodio, quanto frequentemente accade?
- Patologie della madre durante la gravidanza ?

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

URGENZE PEDIATRICHE

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

URGENZE PEDIATRICHE

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

OBIETTIVI

Saper essere: gestire l'ansia che solitamente accompagna il soccorritore nell'evento

Saper fare: mettere in atto i principali provvedimenti assistenziali di base

Sapere: riconoscere rapidamente i segni clinici di insufficienza respiratoria in età pediatrica

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Cosa valutare

Stato di coscienza: agitazione, sopore ...

Parametri vitali: FR – FC – Sat. O₂ (se possibile)

Modalità di respiro:

- Utilizzo muscolatura accessoria;
- Alitamento delle pinne nasali;
- Rientramento del giugulo;
- Rumori respiratori patologici (sibili, fischi, gemiti)

Colorito cutaneo: cianosi, pallore, arrossamento

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

tipologie di respiro

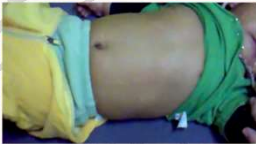
ALITAMENTO PINNE NASALI



TIRAGE



STRIDORE con rientramenti



per gentile concessione della dott.ssa PAOLA DE STEFANIS, 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Civile S. Maria della Misericordia, Udine.

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

tipologie di respiro

RIENTRAMENTI E ALITAMENTO PINNE NASALI



STRIDORE



per gentile concessione della dott.ssa PAOLA DE STEFANIS, 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Civile S. Maria della Misericordia, Udine.

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Cosa chiedere

- Breve anamnesi su precedenti problemi respiratori o cardiologici
- Eventuale terapia in atto
- Presenza di febbre recente
- Modalità di insorgenza del quadro: acuto, progressivo, ricorrente

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Esaurimento Respiratorio

Segnali di PERICOLO

Deterioramento della coscienza

Perdita del tono muscolare

Presenza di cianosi

Frequenza respiratoria molto elevata

Respiro inefficace

Bradicardia (FC < 80/min)



WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Assistenza

BAMBINO TONICO E COSCIENTE

Obiettivo: non aggravare la dispnea aumentando le richieste di ossigeno

MANTENERE TRANQUILLO IL BAMBINO

- Rispettare la posizione scelta dal bambino per respirare
- Non allontanare i genitori
- Fornire ossigeno se possibile

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Assistenza

ESAURIMENTO RESPIRATORIO

Eseguire rapida valutazione ABCDE
Fornire O₂ ad alti flussi (10-15 l/min)

Posizionare il bambino semiseduto se ancora cosciente; supino se non cosciente

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA CON LA SOREU

ATTENZIONE ALLA RAPIDA EVOLUZIONE VERSO L'ARRESTO RESPIRATORIO

WAREU 118 Emergenza 112



SSE

Conclusioni

L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IN ETÀ PEDIATRICA È UN EVENTO PERICOLOSO, IMPORTANTE È L'IMMEDIATO RICONOSCIMENTO E NELLE FASI DI COMPENSO ASSECONDERE IL BAMBINO SENZA AGGRAVARE I SUOI SFORZI

Nelle fasi di esaurimento CONTINUARE il monitoraggio clinico e considerare la rapida evoluzione (PBLIS)

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

URGENZE PEDIATRICHE

IPERTERMIA (FEBBRE)

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

OBIETTIVI

- Sapere:** riconoscere i segni della febbre alta
- Saper fare:** fornire un'assistenza di base adeguata in caso di febbre
- Saper essere:** superare l'ansia presente nella gestione dell'evento

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

FEBBRE

È un aumento della temperatura corporea superiore a 37° C (cutanea) o superiore a 37,5° C (interna)

VALUTARE L'INSORGENZA E LA DURATA

- Febbre 38° - 39° C
- Febbre "alta" 39° - 40° C
- Febbre "molto alta" 40° - 41° C

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

FEBBRE

LE CAUSE PRINCIPALI SONO LE INFEZIONI DA VIRUS E BATTERI

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

FEBBRE



Come fa l'organismo ad aumentare la temperatura?

- **BRIVIDO:** produce calore
- **VASOCOSTRIZIONE CUTANEA:** riduce la perdita di calore (sensazione di freddo)

WAREL 118 Emergenza 112 Regione Umbria

SSE

FEBBRE



La febbre è un meccanismo di difesa

L'aumento della temperatura corporea impedisce alla maggior parte dei "microbi" di moltiplicarsi ed il sistema immunitario diventa più efficiente.



WAREL 118 Emergenza 112 Regione Umbria

SSE

VALUTAZIONE



ABCDE (Stato di coscienza, Qualità del respiro...)

Difficoltà a muovere la testa

Dolore addominale

Dolore alle orecchie

Disidratazione

CONVULSIONI

WAREL 118 Emergenza 112 Regione Umbria

SSE

VALUTAZIONE



DISIDRATAZIONE

SEGNALI DI DISIDRATAZIONE:

- mucose e cute secche
- diuresi scarsa
- pianto «lamentoso»
- GEMITO**

Rilevare episodi di vomito e diarrea ripetuti /frequenti

WAREL 118 Emergenza 112 Regione Umbria

SSE

ASSISTENZA



Scoprire e favorire la dispersione termica

Le Spugnature

CONSENTONO DI ABBASSARE LA TEMPERATURA CORPOREA RAPIDAMENTE DI 1° - 2° C IN ATTESA CHE L'ANTIPIRETICO FACCIA EFFETTO

Sono indicate quando la temperatura >40° C

Usare acqua tiepida

WAREL 118 Emergenza 112 Regione Umbria

SSE

Quando gli antipiretici ?




PRESCRIZIONE MEDICA !!!!

Sempre se la temperatura >40° C

Se temperatura >39° C con sintomi fastidiosi

Febbre lieve ma con mal di testa o dolori

Attenersi alle indicazioni della **SOREU**

WAREL 118 Emergenza 112 Regione Umbria



SSE

CONCLUSIONI

LA FEBBRE IN ETÀ PEDIATRICA È UN EVENTO FREQUENTE IMPORTANTE È L'IMMEDIATO RICONOSCIMENTO DELLA FEBBRE ALTA E LA RACCOLTA ACCURATA DEI SEGNI DI DISIDRATAZIONE

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

URGENZE PEDIATRICHE

CONVULSIONI

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

OBIETTIVO

Sapere: riconoscere l'insorgenza delle crisi convulsive valutandone le principali caratteristiche

Saper essere: gestire l'ansia che solitamente accompagna il soccorritore nell'evento

Saper fare: fornire un'assistenza di base adeguata nella fase critica e post-critica

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

COVULSIONI

- Evenienza clinica frequente in età pediatrica
- Generalmente sono autolimitanti, già esaurite all'arrivo dei soccorsi
- In rari casi sono, invece, più durature e severe e rappresentano un vero problema clinico

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

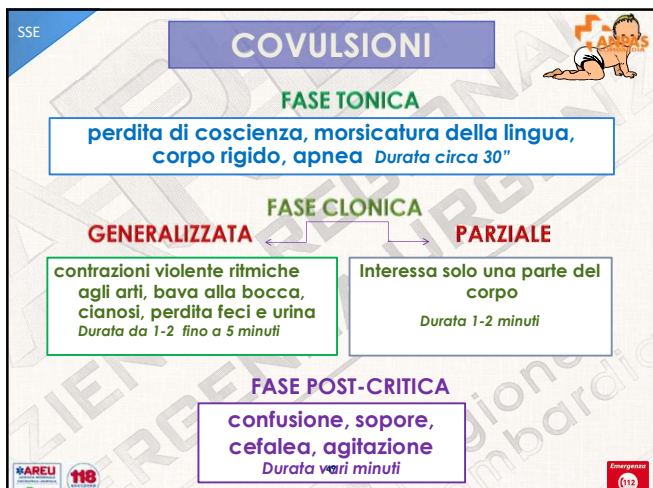
COVULSIONI

Eventi acuti e improvvisi a carico del SNC caratterizzati da **contrazioni muscolari involontarie** e **perdita di coscienza**

CAUSE PRINCIPALI

- Malattie ed infezioni del SNC
- Traumi
- FEBBRE e colpo di calore
- Epilessia
- Ipoglicemia
- Farmaci e sostanze tossiche

WAREL 118 Emergenza 112



SSE

Valutazione

In fase **«critica»**: osserva le caratteristiche e la sede della contrazione, soprattutto se non è bilaterale e simmetrica

In fase **«post-critica»**: valuta la ripresa della coscienza che può non essere immediata e rapidamente soddisfacente

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

Valutazione

- Anamnesi personale o familiare positiva per epilessia ?
- Caratteristiche della crisi: durata, localizzazione, perdita di urine o feci
- Presenza di febbre o di altre malattie al momento della crisi ?
- Recente trauma cranico ?

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

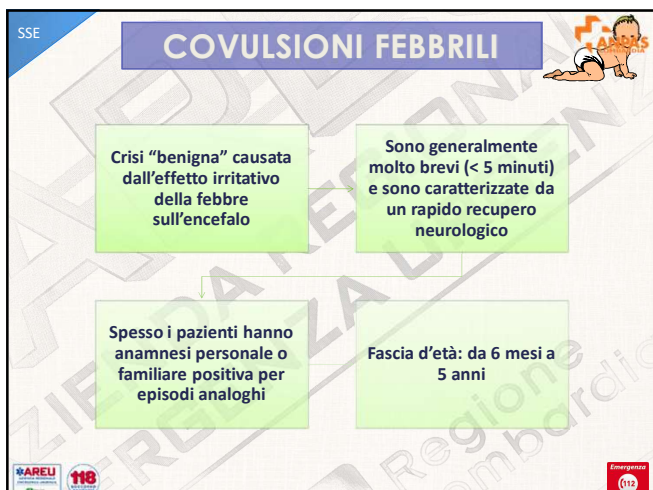
ASSISTENZA

In fase **«critica»**: non trattenere, allontana ogni oggetto per evitare lesioni traumatiche secondarie

In fase **«post-critica»**: valuta ABCDE supporta con O₂ ad alti flussi, monitorizza le funzioni vitali

Attieniti alle indicazioni della **SOREU**

WAREL 118 Emergenza 112



SSE

COVULSIONI FEBBRILI

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SI MANIFESTANO NELLE PRIME 24 - 36 ORE DI FEBBRE

NEI PAZIENTI NOTI È INDICATA L'ASSUNZIONE DI ANTIPIRETICI (INDICAZIONE MEDICA) ANCHE SE LA TEMPERATURA CUTANEA NELLE PRIME 24-36 ORE È ≥ 37.5°C

NEI PAZIENTI NOTI, I GENITORI MOLTO PROBABILMENTE SONO ISTRUITI SULL'USO DI FARMACI SPECIFICI PER VIA RETTALE*

WAREL 118 Emergenza 112



SSE

CONCLUSIONI

Generalmente le convulsioni in età pediatrica sono fenomeni benigni di breve durata

In fase critica osservarne le caratteristiche

In fase post-critica mantenere un attento monitoraggio clinico e neurologico

WARELI 118 Emergenza

Emergenza 112

SSE

Urgenze Pediatriche

AVVELENAMENTI

Esposizione a materiale pericoloso

possono avvenire a qualsiasi età e spesso sono coinvolte più persone

WARELI 118 Emergenza

Emergenza 112

SSE

Obiettivi

Sapere: riconoscere i segni e sintomi principali in caso di avvelenamento

Saper fare: fornire un'assistenza di base adeguata. Raccogliere l'agente intossicante

Saper essere: superare l'ansia presente nella gestione dell'evento

WARELI 118 Emergenza

Emergenza 112

SSE

Differenze per età

PRIMI PASSI ED ETÀ PRE-SCOLARE:

- non intenzionale
- singola sostanza
- piccola quantità

WARELI 118 Emergenza

Emergenza 112

SSE

Differenze per età

ETÀ SCOLARE:

- Per gioco, esperimento emulazione

WARELI 118 Emergenza

Emergenza 112

SSE

Differenze per età

ADOLESCENZA :

- Spesso intenzionale (a scopo suicida)
- Sostanze euforizzanti o analgesici
- A volte più di una sostanza
- Spesso in grossa quantità



WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Valutazione

ABCDE

ANAMNESI – AMPIA:

- quale sostanza?
- in che quantità?
- da quanto tempo?
- peso del bambino ?

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Valutazione

- Fai attenzione alla possibilità della presenza di sostanze tossiche sui vestiti o sulla cute
- Osserva l'ambiente: porta contenitori di sostanze sospette, piante, siringhe, avanzi di alimenti, vomito, ecc. in pronto soccorso (se possibile)

Attenersi alle indicazioni della SOREU

WAREU 118 Emergenza 112

SSE



WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Conclusioni

L'avvelenamento si riscontra in qualunque fascia d'età

Nei pazienti pediatrici è un'eventualità da sospettare sempre

WAREU 118 Emergenza 112